

# Mirror Soul

## Reporte generado por IA

Paciente: 4

Sesión: 266

Fecha: Sun Aug 16 2026 17:27:22 GMT-0600 (hora estándar central)

### Contenido

Aquí tienes el reporte final preliminar basado en la información proporcionada:

---

**\*\*Reporte Final Preliminar de Sesión\*\***

**\*\*Paciente:\*\*** Luci, 11 años, F

---

#### **\*\*1. Resumen Clínico Breve\*\***

Luci, una paciente femenina de 11 años, presenta antecedentes emocionales de depresión, confirmados por la evaluación inicial. Existe una sospecha diagnóstica inicial de ansiedad que requiere confirmación mediante pruebas. En los antecedentes, se observa el hábito de morderse los labios. Su desarrollo escolar ha sido descrito como bueno y sin dificultades significativas. Actualmente, se encuentra bajo medicación con metformina e histofil, cuya relevancia para su estado emocional o historial médico no ha sido detallada en el contexto de la sesión actual. La sesión actual se enfocó en la necesidad de realizar pruebas diagnósticas para clarificar su cuadro clínico.

#### **\*\*2. Patrones Observados en Pruebas y Notas\*\***

\* **\*\*Ausencia de Pruebas:\*\*** La observación más destacada es la ausencia de resultados de pruebas psicológicas en esta sesión, lo cual es consistente con la nota de "realizar pruebas" en el historial inicial y el diagnóstico preliminar de "ansiedad pero faltan pruebas". Esto subraya la fase inicial del proceso de evaluación.

\* **\*\*Consistencia en Referencia a Depresión:\*\*** Se observa un patrón consistente en la mención de "depresión" tanto en los antecedentes emocionales como en la evaluación inicial, lo que sugiere que esta ha sido una preocupación central desde el inicio.

\* **\*\*Indicador Comportamental:\*\*** El hábito de "morderse los labios" podría ser un indicador de ansiedad, estrés o nerviosismo, lo que refuerza la necesidad de investigar la posible presencia de un trastorno de ansiedad.

\* **\*\*Clarificación Diagnóstica Necesaria:\*\*** El patrón general indica una necesidad crítica de diferenciar o co-evaluar la depresión y la ansiedad, ya que ambas han sido señaladas como posibles presentaciones.

#### **\*\*3. Riesgos Detectados\*\***

\* **\*\*Riesgo de Malestar Emocional Continuo:\*\*** La falta de un diagnóstico claro y la ausencia de tratamiento específico (señalado como "aun no hay") para la depresión y/o ansiedad puede llevar a la persistencia o exacerbación del malestar emocional en Luci.

\* **\*\*Impacto Potencial en el Desarrollo:\*\*** A pesar de un buen desempeño escolar actual, la depresión y/o ansiedad no tratadas en la preadolescencia pueden afectar el rendimiento académico futuro, las relaciones sociales y el desarrollo de la autoestima.

\* **\*\*Comorbilidad No Detectada:\*\*** Existe el riesgo de no identificar otras condiciones comórbidas si no se realiza una evaluación exhaustiva.

\* **\*\*Riesgos asociados a la depresión:\*\*** Aunque no hay datos específicos en esta sesión, es fundamental recordar los riesgos generales asociados a la depresión en adolescentes, incluyendo el aislamiento social, la anhedonia y, en casos más severos, ideación suicida, lo cual requiere vigilancia en

futuras evaluaciones.

**\*\*4. Recomendaciones de Seguimiento\*\***

\* **\*\*Evaluación Diagnóstica Completa:\*\*** Proceder de inmediato con la administración de pruebas psicológicas estandarizadas para evaluar la presencia y severidad de la depresión (ej. CDI-2, BDI-Y) y la ansiedad (ej. SCARED, MASC-2) apropiadas para la edad de Luci.

\* **\*\*Entrevista Clínica Profunda:\*\*** Realizar una entrevista clínica detallada con Luci y sus cuidadores para recopilar información sobre la cronología, desencadenantes, impacto funcional de los síntomas, historia familiar de salud mental y recursos de afrontamiento.

\* **\*\*Observación Continuada:\*\*** Monitorear el hábito de morderse los labios y otros comportamientos no verbales que puedan indicar ansiedad o angustia.

\* **\*\*Revisión Farmacológica:\*\*** Se recomienda obtener información adicional sobre la prescripción y el propósito de los medicamentos actuales (metformina, histofil) con los padres/médico tratante, para entender su posible interacción con el estado emocional o cualquier condición médica subyacente.

\* **\*\*Plan de Intervención:\*\*** Una vez completada la evaluación, desarrollar un plan de tratamiento individualizado, que podría incluir terapia cognitivo-conductual (TCC), terapia familiar, psicoeducación o, si es necesario, derivación para evaluación psiquiátrica.

**\*\*5. Observaciones sobre Multimedia\*\***

No se registró el uso de multimedia (videos, grabaciones de audio, aplicaciones interactivas) durante la sesión, ni se adjuntaron resultados de pruebas en formato multimedia. La información se basa únicamente en el historial inicial proporcionado.

**\*\*6. Nota Aclaratoria\*\***

Este reporte es preliminar y se basa exclusivamente en la información inicial proporcionada. No constituye un diagnóstico clínico definitivo. Se requiere una evaluación psicológica completa y la recopilación de datos adicionales para establecer un diagnóstico preciso y un plan de intervención adecuado.

---